

Найти анали

Войдите, чтобы посмотреть
результаты анализов Москва

Инвитро / Библиотека / Предменструальный...

Предменструальный синдром (ПМС)

 138237 Написано: 11.02.2021 Отредактировано: 22.10.2025[Головная боль](#)[Диарея](#)[Отек](#)[Паническая атака](#)[ПМС](#)[Предменструальный синд](#)

Предменструальный синдром: причины появления, при каких заболеваниях возникает, диагностика и способы лечения.

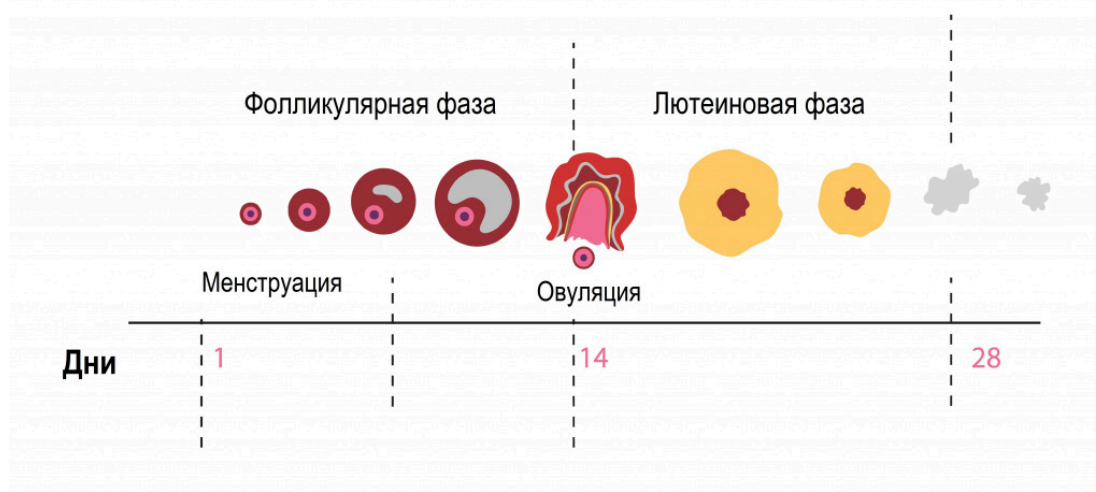
Определение

Плаксивость, раздражительность, необоснованный гнев (по мнению окружающих), болезненные ощущения в области живота и поясницы, чувство тоски и тревоги, головная боль, отеки – эти и многие другие симптомы связывают с развитием предменструального синдрома, или ПМС. Является ли ПМС тем состоянием, которое нужно лечить?

Предменструальный синдром – это комплекс патологических симптомов, который включает в себя разнообразные психоэмоциональные, соматовегетативные и обменно-эндокринные проявления, начинающиеся во время лютеиновой фазы цикла, которая длится примерно 14 дней перед началом менструации, и исчезающие в первые ее дни.

Таким образом, все симптомы ПМС могут появиться как сразу после овуляции, так и за один-два дня до начала очередной менструации.

Фазы менструального цикла



Изображение используется согласно лицензии Shutterstock.

Разновидности ПМС

В зависимости от того, какие симптомы преобладают в проявлении предменструального синдрома, выделяют следующие его формы:

- отечную;
- цефалгическую;
- кризовую;
- нейروпсихическую;
- атипичную.

Отечная форма ПМС характеризуется отеками лица, голеней, пальцев рук и связанной с ними прибавкой веса. Возможны такие проявления, как нагрубание молочных желез, потливость, кожный зуд и функциональные расстройства кишечника (запоры, диарея, повышенное газообразование). Все перечисленные симптомы исчезают в начале менструации и редко требуют обращения за медицинской помощью.

Для цефалгической формы ПМС характерны сильные головные боли, чаще односторонние, пульсирующие, усиливающиеся при движении. Подобные боли сопровождаются раздражительностью, повышенной чувствительностью к запахам, агрессией, тошнотой, болью в области сердца. Цефалгическая форма ПМС встречается у женщин, перенесших черепно-мозговую травму или нейроинфекцию, а также страдающих артериальной гипертензией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Боли проходят по окончании лютеиновой фазы менструального цикла.

Кризовая форма ПМС характеризуется преобладанием симпатоадреналовых кризов (нечто похожее на панические атаки), сопровождающихся повышением артериального

давления, учащением сердечных сокращений, болями в области сердца без изменений на ЭКГ. Подобные приступы могут заканчиваться усиленным мочеотделением.

Нейропсихическая форма ПМС включает в себя ряд симптомов, на которые женщина обычно не обращает внимания. Они регулярно появляются перед началом менструаций и являются поводом для консультации с врачом: раздражительность, плаксивость, бессонница, агрессия, депрессивное состояние, быстрая утомляемость, сексуальные нарушения, суицидальные мысли и различные галлюцинации.

Нейропсихическая форма часто сочетается с другими формами, особенно в тяжелых случаях ПМС.

Атипичная форма ПМС встречается редко, проходит под маской других заболеваний – бронхиальной астмы, язвенного гингивита или стоматита, иридоциклита, миокардиопатии.

По тяжести течения выделяют легкую форму ПМС – за 2–10 дней до менструации появляется до четырех симптомов, при этом до двух симптомов выражены в значительной степени.

При тяжелой форме ПМС появляется более пяти симптомов за 3–14 дней до начала менструации, и из них многие выражены в значительной степени.

Возможные причины развития предменструального синдрома

Частота возникновения ПМС зависит от возраста женщины. Если в возрасте до 30 лет симптомы ПМС возникают лишь у 20% женщин, то после 30 лет ПМС встречается почти у каждой второй.

К развитию предменструального синдрома предрасположены эмоционально-лабильные женщины, астенического телосложения, часто с дефицитом массы тела.

Также к факторам риска развития ПМС относят:

- частые стрессовые ситуации дома и на работе;
- осложненные роды;
- аборты в анамнезе;
- оперативные вмешательства;
- нейроинфекции;

- частую смену климатических зон;
- наличие хронических гинекологических заболеваний.

По современным данным, решающее значение в развитии негативных симптомов имеет изменение чувствительности к гормону прогестерону. Роль триггерного механизма в процессе возникновения ПМС играет нормальное изменение уровня половых гормонов в ходе менструального цикла. Во второй половине цикла (лютеиновой фазе) основное влияние на организм женщины оказывает прогестерон.

Прогестерон опосредованно влияет на динамичное изменение уровня секреции серотонина. Именно эта система обеспечивает регуляцию настроения на уровне нейронов.

Считается, что в лютеиновую фазу менструального цикла происходит удлинение времени обработки отрицательных эмоций в структурах головного мозга и снижение контроля за уровнем выраженности эмоций.

Еще одним механизмом, затрагивающим изменение уровня серотонина в головном мозге, является постоянный стресс, длительные переживания неразрешенных конфликтных ситуаций, страх, ожидание реальных или воображаемых событий. Тревожность в большинстве случаев повышает аппетит, а «заедание плохого настроения» приводит к развитию метеоризма и других диспепсических расстройств (запоров и диареи), что вносит свой вклад в течение предменструального синдрома.

Огромную роль в развитии ПМС играет наследственная предрасположенность.

К каким врачам обращаться при ПМС

Если проявления ПМС мешают вести полноценную социальную и личную жизнь, для решения этой проблемы следует обратиться к [гинекологу](#).

Важно исключить наличие другой соматической патологии, которая может ухудшать течение второй фазы менструального цикла. Для этого нужно обратиться к [терапевту](#). Если потребуется, врач направит на необходимые лабораторно-инструментальные обследования и консультации узких специалистов.

Если органическая причина заболевания не найдена, необходимо обратиться за консультацией к психиатру для определения тактики преодоления тревожности и других стрессовых состояний.

Диагностика и обследования при ПМС

В ходе диагностики предменструального синдрома важная роль отводится ведению пациенткой дневника в течение нескольких циклов.

В нем отмечаются все симптомы ПМС, их выраженность в баллах от 0 до 10. В ходе исключения соматической и нейроэндокринной патологии выполняется комплекс лабораторно-инструментальной диагностики в зависимости от симптоматической картины.

- Гормональное исследование крови: фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), пролактин, тестостерон, эстрадиол, адренокортикотропный гормон (АКТГ), тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3), тиреотропный гормон (ТТГ).

🕒 1 день > 🚗 Выезд на дом

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle Stimulating Hormone, FSH)

№ 59 | Один из тестов для диагностики патологий репродуктивной системы как у женщин, так и у мужчин.

840 ₹

Взятие биоматериала +310₹

🔵 +25 бонусов

В корзину за 840 ₹



🕒 1 день > 🚗 Выезд на дом

Лютеинизирующий гормон (ЛГ, Luteinizing Hormone, LH)

№ 60 | Для исследования функционального состояния репродуктивной системы; для диагностики женского и мужского бесплодия. При нарушениях менструального цикла и фертильности, поликистозе яичников, при контроле гормонотерапии, обследовании перед ЭКО.

840 ₹

Взятие биоматериала +310₹

🔵 +25 бонусов

В корзину за 840 ₹



🕒 1 день > 🚗 Выезд на дом

Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мМЕ/л)

№ 61 | Гормон гипофиза, который участвует в регуляции развития молочных желез и лактации. Тест используется в диагностике гипоталамо-гипофизарных расстройств и нарушений репродуктивной функции.

Отзыв о сайте

865 ₹

Взятие биоматериала +310₹

🕒 +26 бонусов

В корзину за 865 ₹



🕒 1 день > 🚗 Выезд на дом

Тестостерон (Testosterone)

№ 64 | Основной андрогенный гормон. Используется для диагностики возможных нарушений полового развития у мальчиков, эректильной дисфункции у мужчин, бесплодия у мужчин и женщин.

820 ₹

Взятие биоматериала +310₹

🕒 +25 бонусов

В корзину за 820 ₹



🕒 1 день > 🚗 Выезд на дом

Эстрадиол (E2, Estradiol)

№ 62 | Основной и наиболее активный женский половой гормон. Используется для исследования функции яичников при нарушениях менструального цикла, при женском и мужском бесплодии, для контроля гормональной терапии.

825 ₹

Взятие биоматериала +310₹

🕒 +25 бонусов

В корзину за 825 ₹



🕒 1 день >

АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotrophic Hormone, АСТН)

№ 100 | Тест используют в дифференциальной диагностике первичной и вторичной недостаточности коры надпочечников, болезни и синдрома Иценко-Кушинга.

1 245 ₹

Взятие биоматериала +310₹

🕒 +37 бонусов

В корзину за 1 245 ₹



🕒 1 день > 🚗 Выезд на дом

Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4)

№ 55 | Свободный, не связанный с транспортными белками плазмы крови тироксин. Для диагностики нарушений функции щитовидной железы и контроля их лечения. Для диагностики врождённого гипотиреоза. В комплексе при обследовании беременных.

785 ₹

Отзыв о сайте

Взятие биоматериала +310₽

+24 бонусов

В корзину за 785 ₽



🕒 1 день > 🚗 Выезд на дом

Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3)

№ 53 | Для функционального исследования щитовидной железы, диагностики и контроля эффективности лечения гипертиреоза.

790 ₽

Взятие биоматериала +310₽

+24 бонусов

В корзину за 790 ₽



🕒 1 день > 🚗 Выезд на дом

Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH)

№ 56 | Гормон гипофиза, регулирующий функции щитовидной железы. Один из важнейших тестов в лабораторной диагностике заболеваний щитовидной железы.

735 ₽

Взятие биоматериала +310₽

+22 бонусов

В корзину за 735 ₽



- **Биохимический анализ крови** (уровень глюкозы крови, контроль уровня холестерина, липопротеинов очень низкой, низкой и высокой плотности).

🕒 1 день > 🚗 Выезд на дом

Глюкоза (в крови) (Glucose)

№ 16 | Основной лабораторный тест для оценки состояния углеводного обмена. Исследование направлено на выявление или оценку риска развития сахарного диабета и других заболеваний, связанных с нарушением обмена углеводов.

385 ₽

Взятие биоматериала +310₽

+12 бонусов

В корзину за 385 ₽



🕒 1 день > 🚗 Выезд на дом

Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total)

Отзыв о сайте

№ 31 | Оценку уровня холестерина в сыворотке крови используют для оценки сердечно-сосудистых рисков, в диагностике нарушений обмена липидов, а также в комплексных обследованиях пациентов с патологией почек, печени, эндокринной системы.

435 ₹

Взятие биоматериала +310₹

+13 бонусов

В корзину за 435 ₹



1 день > Выезд на дом

Холестерин - ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol)

№ 218 | Определение ЛПОНП в сыворотке крови в комплексе с другими липидами применяют в целях дополнительной оценки кардиорисков. Повышенный уровень ассоциирован с увеличением риска развития атеросклеротических изменений.

790 ₹

Взятие биоматериала +310₹

+24 бонусов

В корзину за 790 ₹



1 день > Выезд на дом

Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL)

№ 33 | Определение холестерина ЛПНП в сыворотке крови используют в комплексе с другими тестами липидного профиля для оценки кардиорисков (отражает содержание «плохого холестерина»). Повышение уровня ассоциировано с бóльшим риском атеросклероза.

450 ₹

Взятие биоматериала +1660₹

+14 бонусов

В корзину за 450 ₹



1 день > Выезд на дом

Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol)

№ 32 | Определение холестерина ЛПВП в сыворотке крови используют в комплексе с другими тестами липидного профиля для оценки кардиорисков (отражает содержание «хорошего холестерина»). Повышение уровня ассоциировано с меньшим риском атеросклероза.

475 ₹

Взятие биоматериала +310₹

+14 бонусов

В корзину за 475 ₹



Отзыв о сайте

- Анализ крови на уровень гликированного гемоглобина.

🕒 1 день > 🚗 Выезд на дом

Гликированный гемоглобин (HbA1C, Glycated Hemoglobin)

№ 18 | Соединение гемоглобина с глюкозой, уровень которого отражает среднее содержание глюкозы в крови за предшествующие 1-3 месяца. Тест используют для диагностики и контроля сахарного диабета.

960 ₹

Взятие биоматериала +310₹

🎁 +29 бонусов

В корзину за 960 ₹



- Анализ мочи по Зимницкому.
- Исследование микрофлоры урогенитального тракта.
- Электрокардиографическое исследование (ЭКГ).
- Эхокардиография.
- Маммография.
- Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов.

Ультразвуковое исследование молочных желез

712 |

от 2 590 ₹

Записаться



- Магнитно-резонансная томография головного мозга и надпочечников.

Магнитно-резонансная томография головного мозга

MRT01 |

6 700 ₹

Записаться



Магнитно-резонансная томография позвоночника, пояснично-крестцовый отдел

MRT16 |

6 920 ₹

Записаться



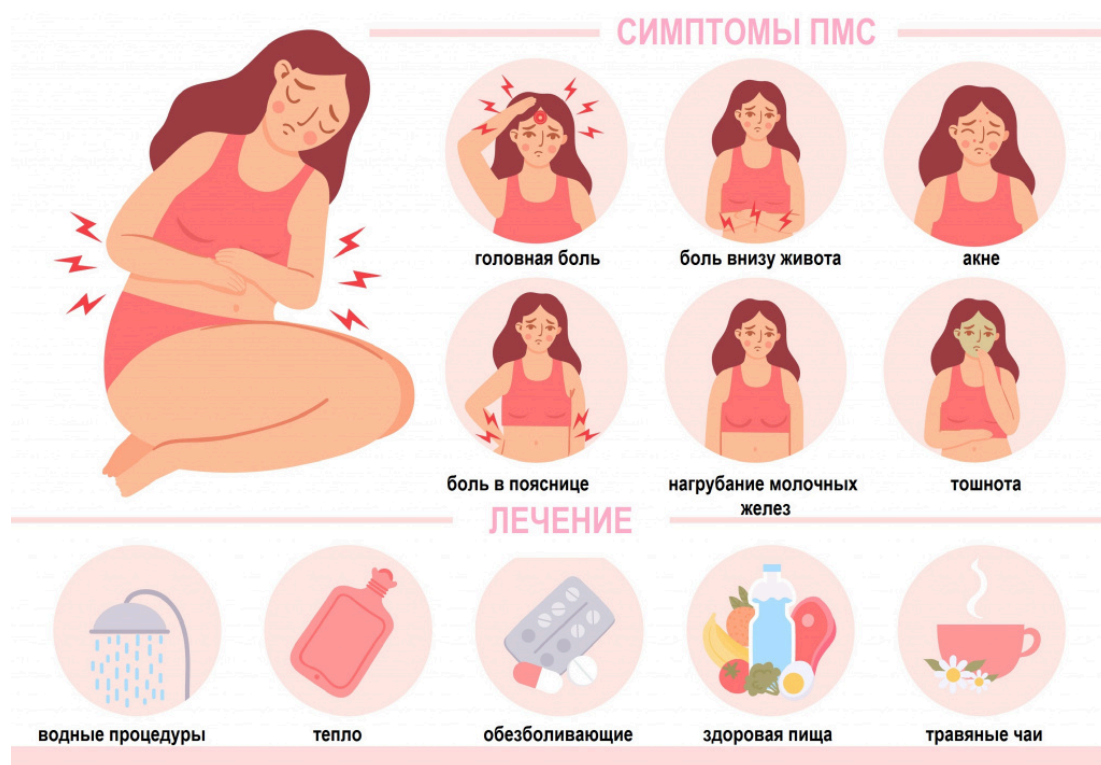
Отзыв о сайте

Что делать при ПМС

Профилактика и уменьшение выраженности предменструального синдрома основывается на изменении привычного образа жизни и витаминотерапии.

По возможности необходимо исключить стрессовые ситуации, резкие смены климата, применение комбинированных оральных контрацептивов.

Кроме того, нельзя злоупотреблять кофеином и алкоголем, также желательно принимать пищу небольшими порциями в течение всего дня. Для профилактики раздражительности и усталости рекомендуется принимать витамины B6 и E, магний, кальций.



Изображение используется согласно лицензии Shutterstock.

Лечение ПМС

Для снижения уровня беспокойства, которое становится причиной повышения аппетита («заедания стресса»), приводящего, в свою очередь, к диспепсии, рекомендуется соблюдать диету, направленную на повышение содержания серотонина.

Продукты с большим количеством триптофана помогают в решении этого вопроса: йогурты, сыры, творог, бананы, грибы, финики.

Также важно соблюдать режим отдыха, ведь уставший человек более чувствителен к внешним раздражителям и способен на неадекватные реакции в ответ на воздействие.

Из других немедикаментозных методов лечения используют различные виды массажа, физиотерапию, рефлексотерапию и санаторно-курортное лечение.

Для снятия напряжения рекомендуются аэробные физические упражнения по 20–30 минут 3 раза в неделю при отсутствии противопоказаний.

В некоторых сложных случаях и после проведения необходимых исследований врач может назначить гормональную терапию прогестероном или эстроген-гестагенными препаратами. Также при некоторых формах ПМС рекомендуется применение антидепрессантов и методов психотерапии.

Источники:

1. Яковлева Э.Б., Бабенко О.М., Пилипенко О.Н. Предменструальный синдром. Медицина неотложных состояний, журнал. № 3 (58), 2014. С. 159-163.
2. Гулиева Л.П., Юренева С.В. Предменструальный синдром: клиника, диагностика и терапевтические подходы. Медицинский совет, журнал. № 2, 2017. С. 106-111.

Важно!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

У вас остались вопросы? Запишитесь на прием к врачу в вашем городе по тел. 8 (495) 363-0-363; 8 (800) 200-363-0.

Отзыв о сайте

Поделиться статьей



Информация проверена экспертом



Лишова Екатерина Александровна

Высшее медицинское образование, опыт работы - 19 лет.

Полезные статьи

INVITRO

Симптомы

Справочник заболеваний

Лабораторная диагностика

Вакцинопрофилактика

Инструментальная диагностика

Чем болеют наши дети

Интервью с экспертами

Об ИНВИТРО

История компании

Вакансии

Партнёры

Клинические исследования

Еще

Юридическая информация

Персональные данные

Политика конфиденциальности

Лицензии и сертификаты

Справка для ФНС

Правила оказания услуг

Еще

Лояльность

Акции

Отзыв о сайте

Подарочные сертификаты

Кешбэк

Прессе

Новости

Пресс-релизы

Фото и видео

Организациям

Медицинским организациям

Немедицинским организациям

Франчайзинг

Врачам

Корпоративным клиентам

Поставщикам

Скачать приложение

© ООО «ИНВИТРО-Объединенные коммуникации», 1998 — 2026 • Адрес: 121059, город Москва, Киевская ул, д. 7 к. 2, помещ. 1, адрес электронной почты info@invitro.ru • Информация, предоставляемая на сайте www.invitro.ru, предназначена для поддержки, а не для замещения существующих отношений между пациентом и его лечащим врачом.

Все права защищены и охраняются законом. © ООО «ИНВИТРО-Объединенные коммуникации» • Копирование, тиражирование, а равно иное использование материалов, размещенных на сайте www.invitro.ru возможно только с письменного разрешения Правообладателя.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии



18+



Отзыв о сайте